

FÁRMACOS MÁS UTILIZADOS EN LA URGENCIA

Andrés Fernando Jiménez, Iria Sanles González.

El Servicio de Urgencias exige por parte del personal médico y paramédico un conocimiento amplio y claro de los fármacos más utilizados en las múltiples situaciones que se pueden presentar en dicha área. Este capítulo tiene como objetivo ofrecer una guía básica, concisa y de lectura rápida, de los principales fármacos que a nuestro parecer son imprescindibles en situaciones que requieren actuaciones urgentes. Es importante tener presente que cada institución y/o cada servicio cuenta con un protocolo de dilución y ritmo de perfusión de algunos por no decir de todos los fármacos que mencionaremos a continuación. Sin embargo nuestra intención es mostrar los aspectos mas útiles y relevantes de la información recopilada que dejamos a vuestra consideración.

I. Sedantes, analgésicos y relajantes neuromusculares

Nombre	Indicación	Presentación	Dilución	Volumen concentración final	Dosificación	Observaciones y/o antídoto.
Propofol. Diprivan®	Inducción en IOT y sedación.	-Vial 1%: 20 ml (200mg/20ml o 10mg/ml). -Vial 2%: 50 ml (1000 mg/50 ml o 20mg/ml).	20ml (10mg/ml). 50ml (20mg/ml).	Sin diluir	-Inducción:0.1-1mg/kg -Mantenimiento: 1.5-4.5 mg/kg/hora.	No tiene antídoto descrito.
Midazolam: Dormicum®.	Hipnótico y sedante. Inducción en IOT. Anticonvulsivante.	Viales 5mg/5ml. 15mg/3ml. 50mg/10ml.	5 viales (250mg):5ml. En 200 ml de SGS5% o SSF	250 ml en total. 1ml:1mg.	- Dosis Inicial 0,15-0,4 mg/Kg -Mantenimiento 2-5mcg/Kg/min	Antídoto Flumazenilo.
Fentanilo: Fentanest®	Analgesico dolor moderado a severo.	Vial 0,15 mg o 150mcg/3ml (50mcg/ml).	5 viales 750mcg: 15 ml En 35 ml de SGS5% o SSF.	50 ml en total. 1ml: 15mcg.	-Dosis inicial Bolo 50 a 100 mcg -Mantenimiento 1-2 mcg/kg/hr.	Antídoto Naloxona.
Remifentanilo Ultiva®	Analgesico. dolor moderado a severo	Viales 1mg/3ml 5mg/10ml	1 vial 5mg/10 ml En 90 ml de SGS5% o SSF	100 ml en total 1ml: 0,05mg	0.5 a 1 mcg/kg/min	
Morfico cloruro: Morfina®, Sevredol®.	Analgesico. dolor moderado a severo.	Viales 1% 10mg/1ml.	5 viales (10mg):50mg o 5 ml. En 45 ml de SGS5% o SSF.	50 ml en total. 1ml: 1 mg.	-Dosis inicial: 0,05-0,2 mg/kg -Mantenimiento: (0,01-0.05 mg/kg/hr).0,8-10mg/hr.	Antídoto Naloxona.
Cis-Atracurio Nimbex®.	Bloqueo muscular no despolarizante	Viales 20mg/10ml (2mg/ml).	5amp(20mg): 100mg o 50 ml.	sin diluir	-Dosis Inicial 0,15 mg/Kg. -Mantenimiento 0,06-0,18 mg/Kg/hr.	Jeringas opacas. Para revertir su acción se utilizan los anticolinesterasicos.
Dexmedetomidina Dexdor®	Sedación y control de agitación.	Vial 10mg o (1000mcg)/10ml	1 vial:10ml. En 240 ml de SGS5% o SSF	250 ml. 1ml:4 mcg.	Dosis inicial: 0,2 a 1,4 mcg/kg/h.	

II. Inotropicos y Vasopresores

Nombre	Indicación	Presentación	Dilución	Volumen concentración final	Dosificación	Observación y/o antídoto
--------	------------	--------------	----------	-----------------------------	--------------	--------------------------

Nombre	Indicación	Presentación	Dilución	Volumen concentración final	Dosificación	Observación y/o antídoto
Noradrenalina: Norepinefrina® Norages®.	Vasoplejia o shock distributivo que no responden a reanimación intensa con fluidoterapia.	Vial 10mg/10ml (1mg/1ml).	2amp(10mg):20mg o 20 ml En 80 ml de SGS5%	100 ml 1ml:0,2 mg	0,4-0,6 mcg/kg/min.	
Dopamina: Clorhidrato de dopamina grifols®, Dopamina fides®.	Vasoplejia o shock distributivo que no responden a reanimación intensa con fluidoterapia	Vial 200mg/5ml (40mg/1ml). 200mg/10ml (20mg/1ml)	2amp(200mg):400 mg o 10ml En 240 ml de SGS5% o SSF	250 ml 1ml :1,6 mg	Dosis > Efecto: mcg/kg/min. Dopa 0,5-5 Beta 1:6-9 Alfa 1 > 10	
Dobutamina: Dobutamina® Dobutrex®	Inotropico en Shock cardiogénico	Vial 250mg/20ml (12,5mg/1ml).	1amp(200mg): o 16 ml En 34 ml de SGS5%	50 ml 1ml: 4mg	2,5 a 20 mcg/kg/min.	

III. Vasodilatación

Nombre	Indicación	Presentación	Dilución	Volumen concentración final	Dosificación	Observación y/o antídoto
Nitroglicerina Solinitrina®	Crisis hipertensivas aisladas o en el contexto de (ICC/EAP/IAM)	50 mg/10ml (5mg/1ml)	25mg (1/2 ampolla) En 245 ml de SGS5%	250 ml 1ml:0,1 mg	Dosis inicial: 30 – 100 mcg/kg/min. Aumentos progresivos de 10 mcg/min cada 5 min	
Nitroprusiato.Nitro prussiat fides®	Crisis hipertensivas Aneurismas disecantes de aorta. Shock cardiogénico ICC	Vial 50mg/5ml (10mg/1ml).	1amp(50mg) o 5 ml En 250 ml de SGS5%	250 ml 1ml :0,2mg	Dosis inicial 0,3-0,5 mcg/kg/min	Debe suspenderse progresivamente Protección de la luz
Urapidilo. Elgadi®	Crisis hipertensivas	Vial 50mg/10ml (5mg/1ml).	1amp(50mg) o 10ml	10 ml 1ml: 5mg	- Bolos 25 mg (1/2 ampolla) Es posible repetir la dosis - Mantenimiento: 0,5-6 mg/min	
Labetalol: Trandate®	Crisis hipertensivas Estados Hipertensivos del embarazo	Vial 100mg/20ml (5mg/1ml)	2amp(100mg): 200mg o 40 ml En 160 ml de de SGS5% o SSF	200 ml 1ml:1mg	- Bolos: 50mg (1/2 ampolla) Es posible repetir la dosis - Mantenimiento: 2-15 mg/min	

IV. Otros

Nombre	Indicación	Presentación	Dilución	Volumen concentración final	Dosificación	Observación y/o antídoto.
--------	------------	--------------	----------	-----------------------------	--------------	---------------------------

Nombre	Indicación	Presentación	Dilución	Volumen concentración final	Dosificación	Observación y/o antídoto.
Isoprenalina. Aleudrinal®	BAV de II-III grado. Bradicardias sintomáticas Intoxicación por B Bloq.	Vial 0,2mg/ml	2amp(0,4mg) o 2 ml En 100 cc de SSG5%	104 ml en total 1ml: 0,004mg	- Mantenimiento: 0,1-1,5 microgr/kg/min (máx. 2 microgr/kg/min).	
Amiodarona: Trangorex ®	Antiarrítmico Tratamiento de Arritmia supraventriculares (TPSV, fibrilación y flutter auriculares) y ventriculares (TV y durante RCP de TV/FV refractaria).	Vial 150mg/3ml (5mg/1ml)	6 ampollas (900mg) o 18 ml En 482 ml de SGS5%.	500 ml (1,8mg/ml)	- Mantenimiento: 0,3 - 0,6 mg/kg/h (5 - 10 microgr/kg/min)	

V. Bibliografía

- Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica. Hospital Universitario 12 de Octubre. Fármacos usados en perfusión continua intravenosa Andrea Lázaro Cebas. Carmen García Muñoz. Editorial. 2018.
- Manual de medicina intensiva.J.C Montejo. A. Garcia de Lorenzo. P. Marco. C. Ortiz. Ed. ELSEVIER. 5 Edición. 2017.
- Terapia Intensiva.Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Ed. Medica Panamericana. 5 Edición. 2015
- Farmacos para el corazón. Lionel H. Opie Ed. ELSEVIER. Sexta Edición. 2005
- Chamorro C, Romera MÁ. Grupo de Trabajo de Analgesia y Sedación de la SEMICYUC. Estrategias de control de la sedación difícil. Med Intensiva. 2008;32 Supl 1:31-7.
- Los 101 farmacos de medicina intensiva y urgencias. Elsa Otz Ruiz. Ana Maria Ruiz Ruiz, Tetyana Zhuravetska. Bubok Editorial. ISBN digital: 978-84-686-7204-5. 2008.